

Une jeune femme de 19 ans ayant bénéficié de la vaccination anti-HPV en cours de scolarité, consulte inquiète parce qu'elle a eu un rapport sexuel non protégé. Vous devez savoir en priorité :

Où a eu lieu ce rapport sexuel ?



Quand a eu lieu ce rapport sexuel ?

S'agit-il du 1^{er} rapport sexuel non protégé ?

Est-elle suivie sur le plan gynécologique ?

Le rapport a eu lieu 48h auparavant mais elle n'a pas osé consulter avant ...

Que proposez-vous en premier ?



La contraception d'urgence (« pilule du lendemain »)

Un examen gynécologique

Prescription d'une contraception « fiable »

Prescription d'un TTT anti-rétroviral

Avant de lui administrer la contraception d'urgence (Norlevo® 1cp), vous devez vous assurer de :

L'absence de maladie thrombophilique dans son anamnèse familiale

L'absence de prise concomitante d'ibuprofène

Qu'elle est à jeûn



Aucune des propositions ci-dessus

Elle ne présente aucune plainte mais s'inquiète d'avoir contracté une IST. Votre laboratoire subit de nombreux dysfonctionnements et vous ne pouvez dépister qu'une seule IST... Quel dépistage vous semble prioritaire ?



Chlamydia Trachomatis

Herpès simplex 2

HIV

HPV (Papillomavirus humain)

Pourquoi est-il essentiel de dépister le Chlamydia Trachomatis chez cette jeune fille ?

En cas de test positif le traitement doit être débuté dans les 72h qui suivent le diagnostic

C'est l'IST la plus fréquente

 **Il existe un risque de complications sévères**

Le risque de septicémie est important

Quelle complication est à redouter en cas d'infection à Chlamydia ?

Une prédisposition plus élevée à être contaminé par le virus de l'herpès

Une érythrodermie prurigineuse généralisée

 **Une infertilité**

Un risque plus élevé de prééclampsie en cas de grossesse ultérieure

Votre jeune patiente profite de cette consultation pour vous demander un dépistage du cancer de col de l'utérus (*frottis du col*). Que lui répondez-vous ?

Oui, c'est une excellente opportunité de le faire !



Non, ce dépistage n'est pas indiqué avant 21 ans

Non, le dépistage n'est pas nécessaire étant donné qu'elle a été vaccinée contre HPV

Oui, car elle vous apprend que sa mère a souffert d'un cancer du col de l'utérus à l'âge de 34 ans

Une femme nulligeste de 27 ans en BSH consulte aux urgences en raison de pertes vaginales malodorantes abondantes depuis env. 2 semaines, plutôt blanchâtres, sans douleur abdominale associée ni état fébrile. Elle ne se plaint pas de prurit et l'examen de la vulve ne révèle aucune lésion. Quel est votre diagnostic de présomption ?

Infection latente à HSV (herpès simplex virus)

Pertes physiologiques péri-ovulatoires

Bartholinite

 **Vaginose bactérienne**

Lequel des critères ci-dessous n'appartient pas aux critères diagnostics de vaginose selon Amsel ?

Présence de « clue cells » à l'examen au microscope

pH > 4.5

Libération d'odeur d'amines lors d'application KOH

 **Prédominance de lactobacilles dans la flore vaginale**

Quelle proposition est indiquée chez cette patiente ?

Contrôle bactériologique après traitement

Prescription d'une contraception



Dépistage Chlamydia trachomatis

Régime riche en produits laitiers

Vous êtes appelé(e) par l'infirmière des urgences auprès d'une patiente agitée d'environ 30 ans qui vient d'arriver en ambulance. Elle hurle qu'elle a mal au ventre ! Elle semble fébrile, ne sait pas quand elle a eu ses dernières règles et refuse de répondre à vos questions tant qu'elle n'est pas soulagée ... que faites-vous ?



Test de grossesse + palpation abdominale



[Administration morphine sous-cutanée]

Test de grossesse + échographie gynécologique

Une échographie des voies urinaires

Le test de grossesse est négatif et l'examen de l'abdomen révèle une défense nette en FID. Vous effectuez un examen gynécologique : la palpation bi-manuelle est douloureuse au niveau du col utérin et de l'annexe droite. Pertes vaginales abondantes. T° 38.6C

Vous effectuez une échographie pour exclure une torsion annexielle

Vous l'adrez en chirurgie pour prise en charge d'appendicite

 **Vous suspectez une infection génitale haute et débutez une antibiothérapie i.v.**

Vous organisez une laparoscopie exploratrice

Quel élément de cette situation rend peu probable le diagnostic de torsion annexielle ?

 **T° 38.6C**

Douleur à la palpation bi-manuelle

Test de grossesse négatif

Défense en FID

Une jeune patiente de 22 ans consulte car elle a remarqué l'apparition d'une ulcération vulvaire. Cette lésion lui fait modérément mal. C'est un 1^{er} épisode. L'ulcération est peu profonde. La patiente est sexuellement active depuis l'âge de 17 ans et a eu 6 partenaires. Parmi les causes infectieuses à cet ulcère, quel germe n'est pas à considérer ?

Candida albicans

Herpès simplex

Treponema pallidum

 **Papillomavirus humain**

Une patiente de 25 ans consulte en raison de métrorragies provoquées lors des rapports sexuels. Elle présente des cycles menstruels par ailleurs réguliers et sans particularité. Elle a eu 1 contrôle gynécologique il y a 4 ans. A l'examen au spéculum, on observe une rougeur sur la lèvre antérieure du col évoquant une ectopie. Que faites-vous ?



Frottis cytologique

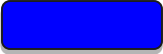
Echographie endovaginale

Biopsie du col

Dépistage VIH

Le résultat de l'examen cytologique confirme l'absence d'anomalies cellulaires (dysplasie). Que souhaiteriez-vous encore exclure ?

Lésion traumatique

 **Infection à Chlamydia**

Vaginose bactérienne

Fausse couche en cours

Une patiente de 46 ans consulte, angoissée, pour obtenir des informations. Elle vient de recevoir une circulaire de l'infirmière scolaire qui incite à vacciner sa fille de 13 ans contre le HPV. Elle ne sait rien de ce virus. Quelle affirmation est erronée ?

La prévalence de HPV est maximale jusqu'à 30 ans

HPV se transmet essentiellement par voie sexuelle

La majorité des infections HPV sont transitoires

 **La vaccination permet d'éviter les contrôles gynécologiques de dépistage du cancer du col**

Cette maman a très peur du cancer ... quel cancer n'est pas, à priori, HPV induit ?

Carcinome épidermoïde anal

 **Ostéosarcome**

Adénocarcinome du col utérin

Cancer de la base de la langue

Parmi les diagnostics suivants, lesquels peuvent être causés par Candida albicans ?



Mycose vaginale

Endométrite



Ulcération vulvaire



Vulvite chronique

Quelle affirmation concernant Chlamydia trachomatis est fausse ?

L'infection est souvent asymptomatique

La GEU est une complication redoutée de l'infection

La diagnostic nécessite une analyse PCR

 **La prévalence en Suisse romande est estimée à 1% chez les femmes de < 26 ans**